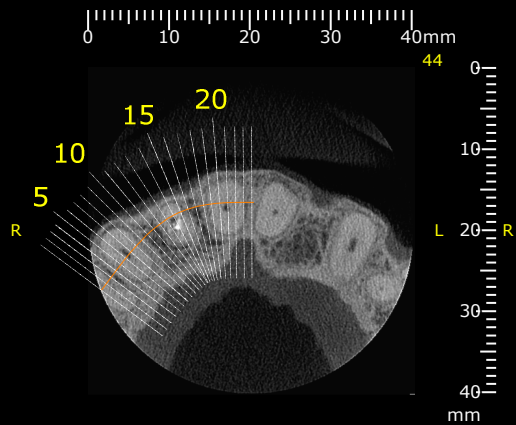


TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

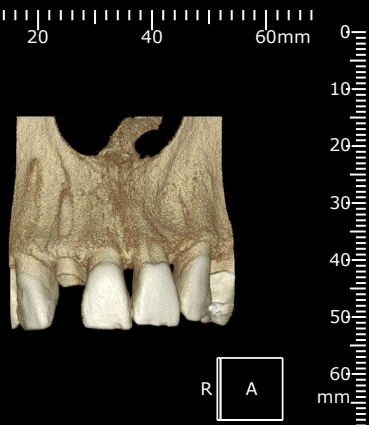
RECONSTRUÇÃO AXIAL



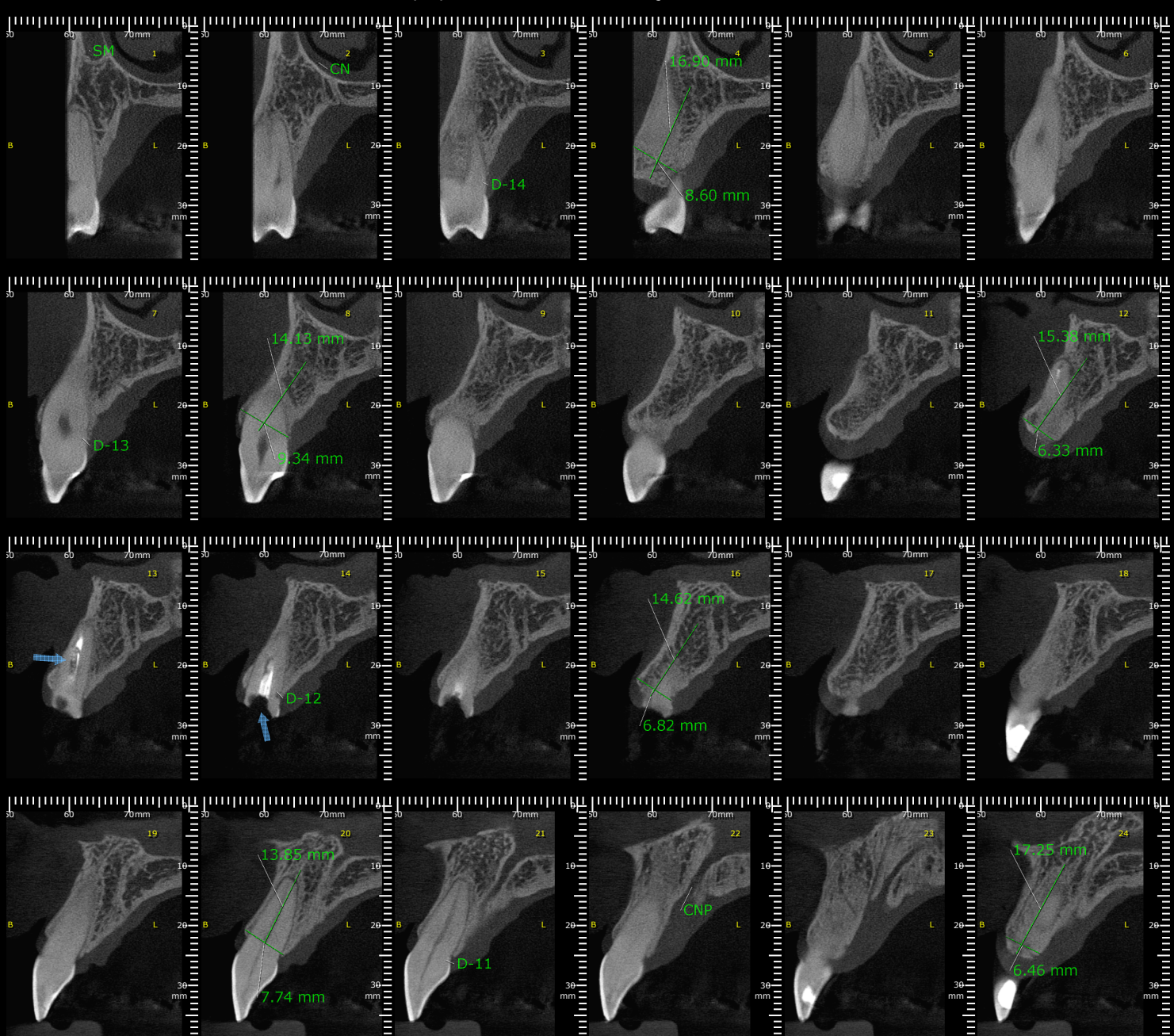
RECONSTRUÇÃO PANORÂMICA



RECONSTRUÇÃO 3D ILUSTRATIVA



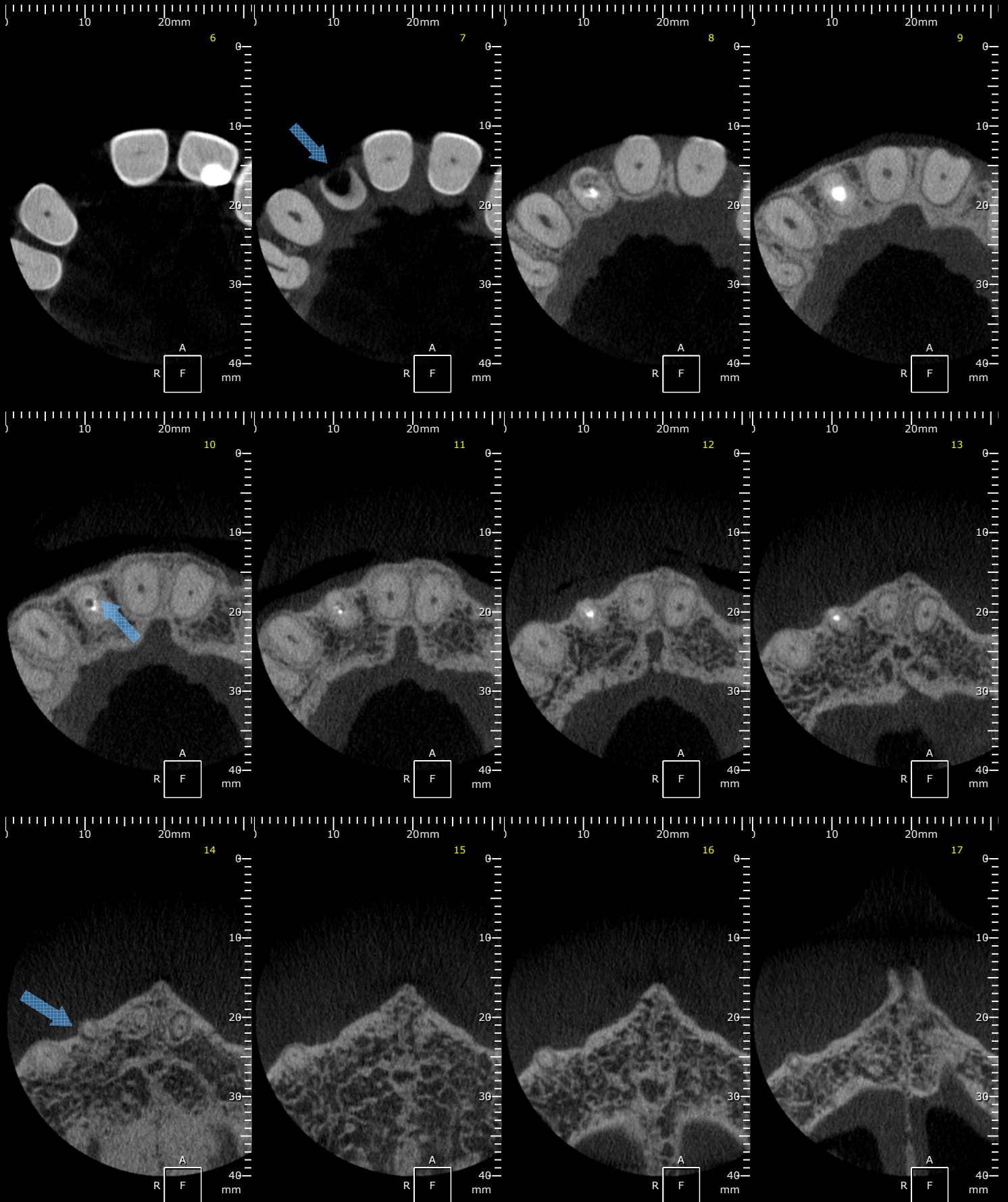
CORTES OBLÍQUOS (1:1), ESPESSAMENTO E ESPAÇAMENTO DE 1MM - TAMANHO REAL



Legendas: SM: Seio Maxilar | CN: Cavidade Nasal | CS: Canalis Sinuosus | CNP: Canal Nasopalatino | CM: Canal da Mandíbula | FM: Forame Mental

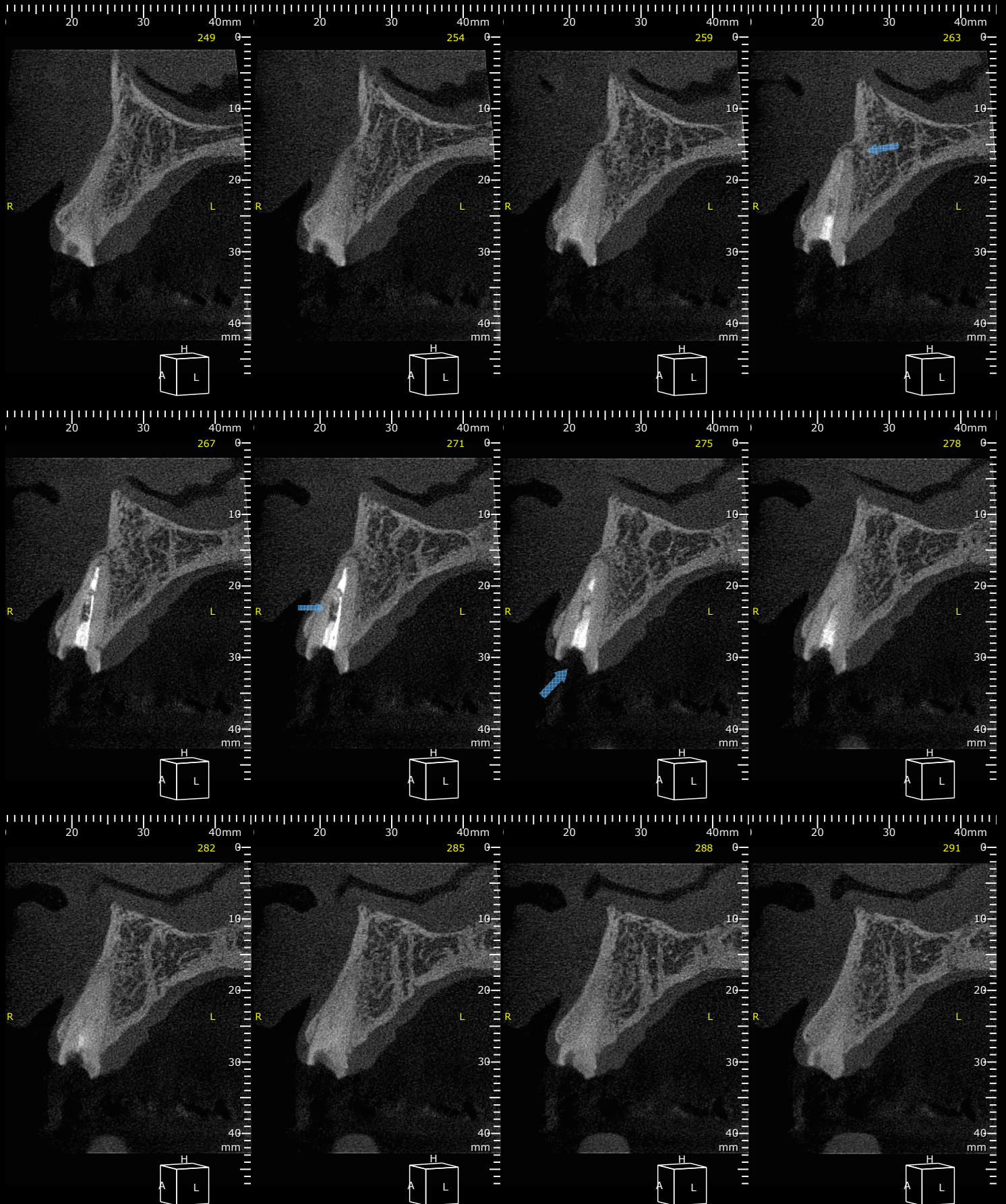
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

RECONSTRUÇÕES AXIAIS



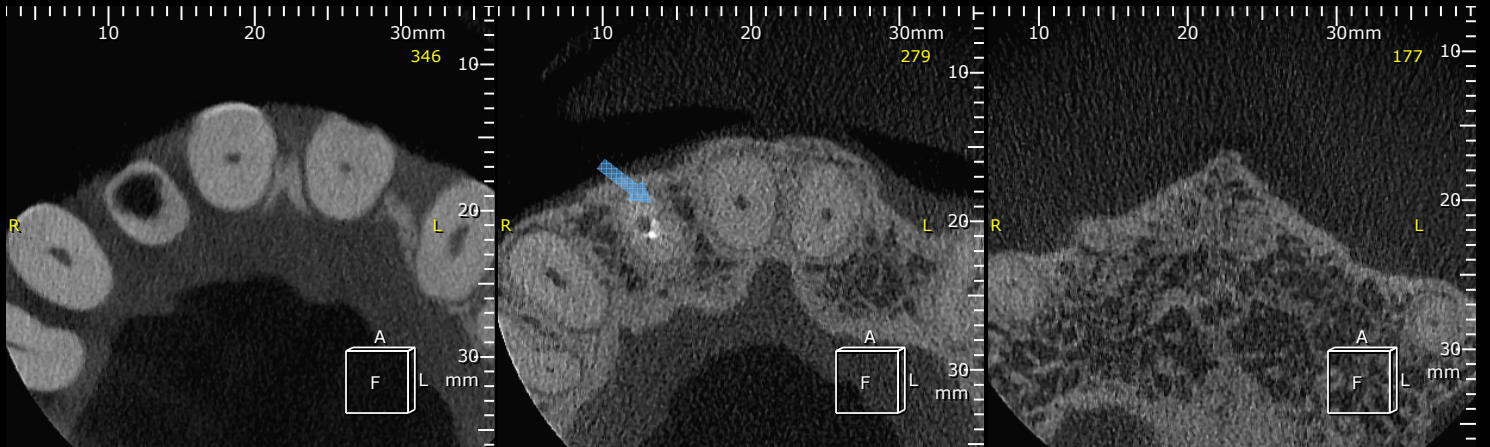
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

RECONSTRUÇÕES SAGITAIS

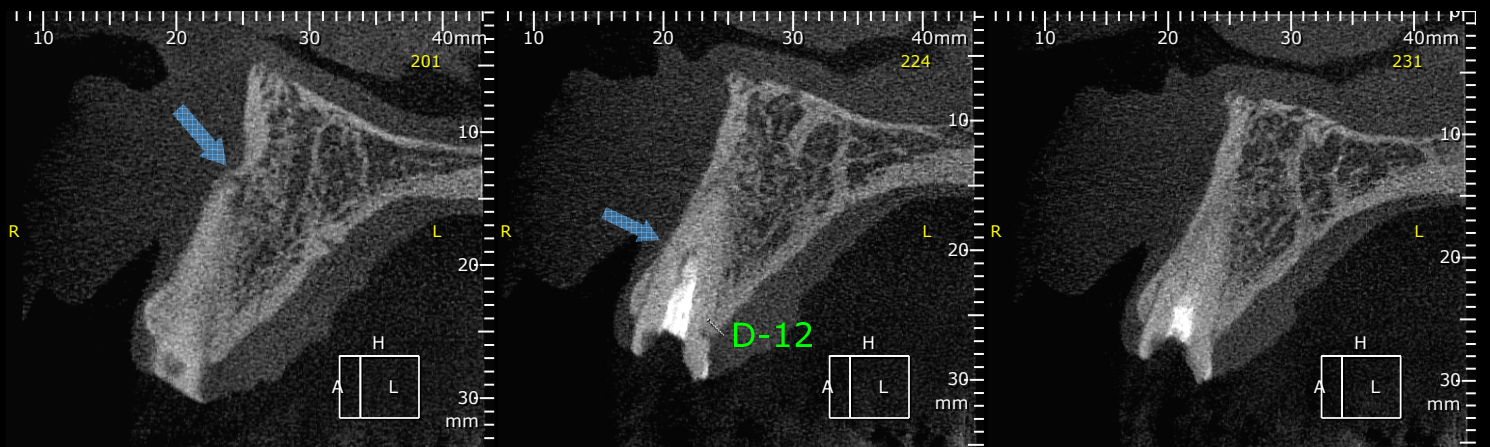


TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

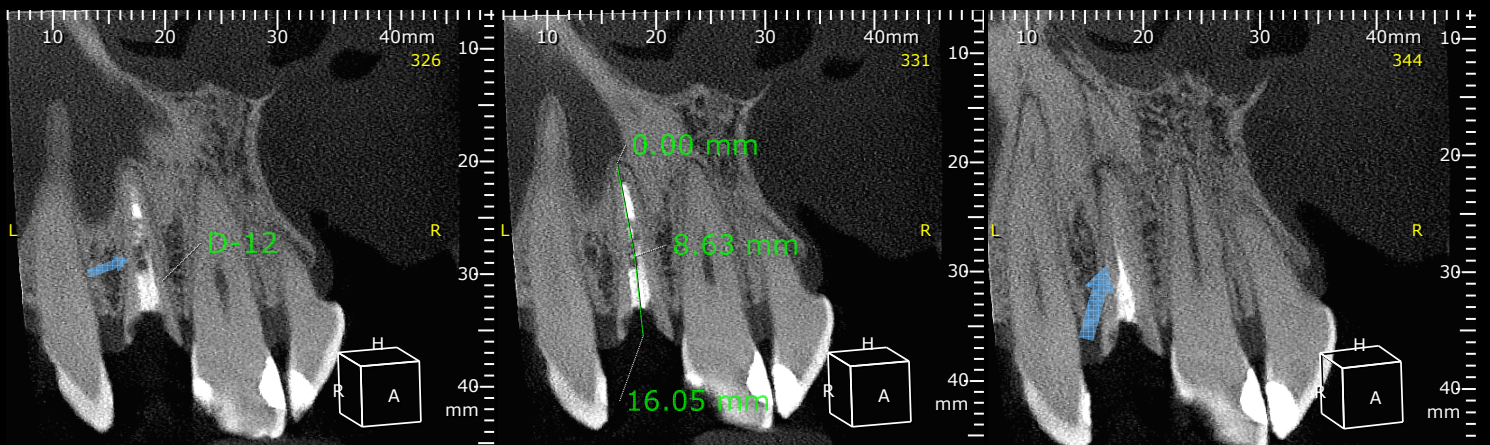
RECONSTRUÇÕES AXIAIS EXTRAS - DENTE 12



RECONSTRUÇÕES CORONAIS EXTRAS - DENTE 12



RECONSTRUÇÕES SAGITAIS EXTRAS - DENTE 12



TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM DO COMPLEXO DENTO-MAXILO-FACIAL

PROTOCOLO

Foram realizadas reconstruções multiplanares, demonstrando:

- Cortes transversais com 0,08 mm de espessura e 1 mm de afastamento entre eles. As imagens encontram-se na escala 1:1 (tamanho real) e numeradas em seu quadrante superior. As imagens coronais panorâmicas e/ou axiais de localização indicam a região correspondente aos cortes transversais, conforme a numeração apresentada entre a imagem de localização e o respectivo corte. Para o estudo, foi considerada a totalidade do volume adquirido, sendo as imagens geradas documentadas em templates específicos, que representam um resumo das imagens reformatadas selecionadas. Ressalta-se que o exame tomográfico constitui método auxiliar de diagnóstico, devendo seus achados ser interpretados em conjunto com os dados clínicos e demais exames complementares pertinentes.
- As reconstruções tridimensionais (3D) possuem caráter exclusivamente ilustrativo.

ÁREA DE ESTUDO SOLICITADA: 12

ANÁLISES GERAIS

- Dentes presentes na incidência solicitada: 13, 12 e 11;
- Presença de restaurações sujeitas a avaliação clínica no(s) dente(s): 13 (MP); 11 (MD);
- Imagem hipodensa compatível com lesão de cárie dentária em coroa e/ou cárie recorrente e/ou ausência de material restaurador no dentes: 13 e 11; Para melhor avaliação e diagnóstico de lesões de cárie dentária recomenda-se radiografias interproximais;
- Dente 12 apresenta extensa destruição coronária, com presença de material hiperdenso no limite apical, ocupando de forma parcial o terço médio do canal radicular; aumento do espaço pericementário na região apical. Nota-se linha hipodensa oblíqua (vide corte axial 10 - seta azul) em terço médio do conduto radicular em estendendo -se por mesial em direção ao espaço periodontal, compatível com linha de trinca/fratura, correlacionar com dados clínicos e história pregressa.
- Cristas ósseas alveolares compatíveis com a idade;
- Em algumas regiões foram realizadas mensurações ósseas, para medidas de outras regiões ou em outras inclinações basta utilizar uma régua milimetrada, já que os cortes apresentam tamanhos reais.
- Ressaltamos que o exame de tomografia computadorizada de feixe cônico, assim como qualquer exame por imagem, é um exame complementar, sendo as informações clínicas de fundamental importância para a conclusão do diagnóstico;

- Para melhor observação dos achados tomográficos descritos acima, sugere-se navegação tridimensional no arquivo DICOM, que segue em anexo ao exame.

OBSERVAÇÕES

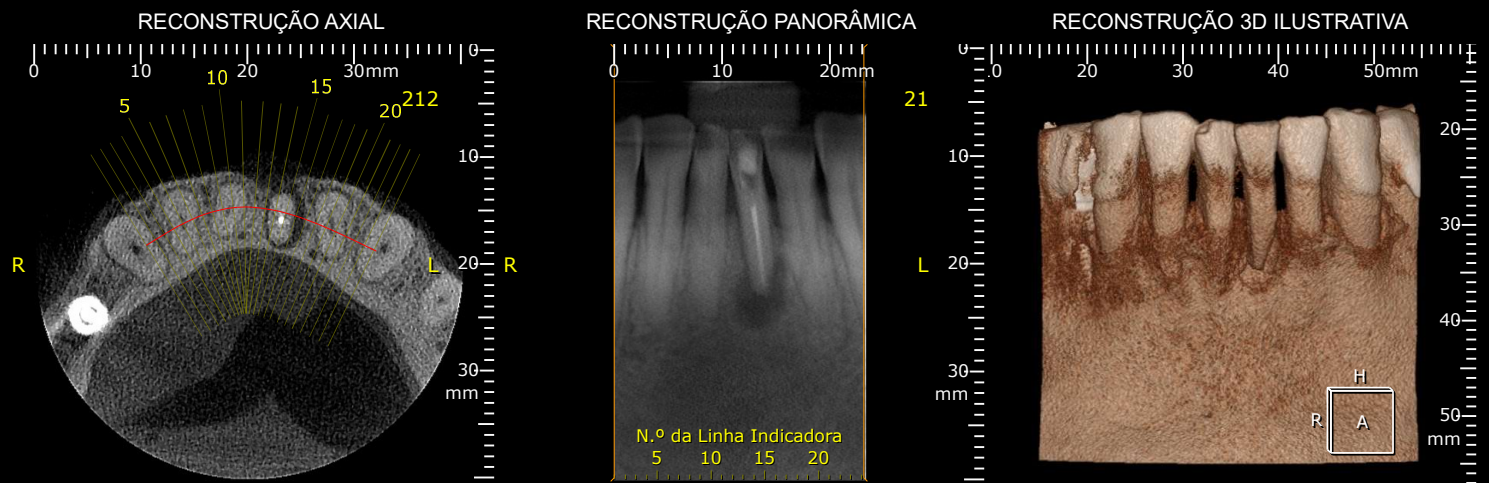
- *As medidas apresentadas nos cortes transversais possuem caráter orientativo, devendo sua interpretação e utilização ser realizadas pelo Cirurgião-Dentista responsável, de acordo com o planejamento clínico e/ou cirúrgico-protético.*
- *Recomenda-se avaliação clínica dos achados tomográficos para melhor elucidação diagnóstica e adequado planejamento terapêutico.*
- *Ressalta-se que artefatos de imagem decorrentes de materiais odontológicos podem limitar a avaliação de determinadas estruturas. Recomenda-se criteriosa correlação dos achados tomográficos com os dados clínicos, radiografias periapicais, exames anteriores e demais exames complementares pertinentes.*

Atenciosamente.

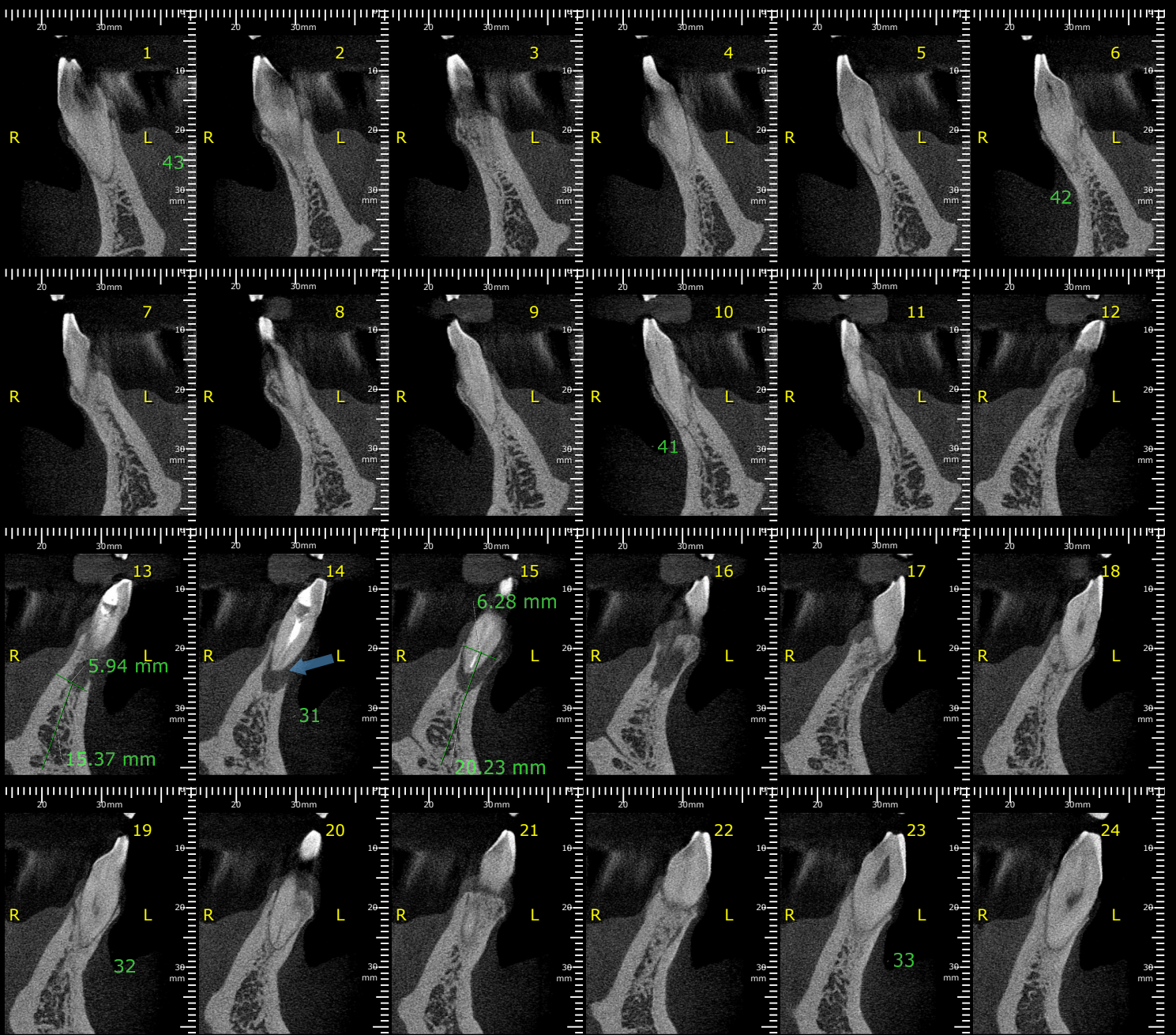


Ms. Sávio Bisinoto de Leles
Mestre e Esp. em Ortodontia
Esp. em Radiologia e Imaginologia Odontológica
CROGO - 15026

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM



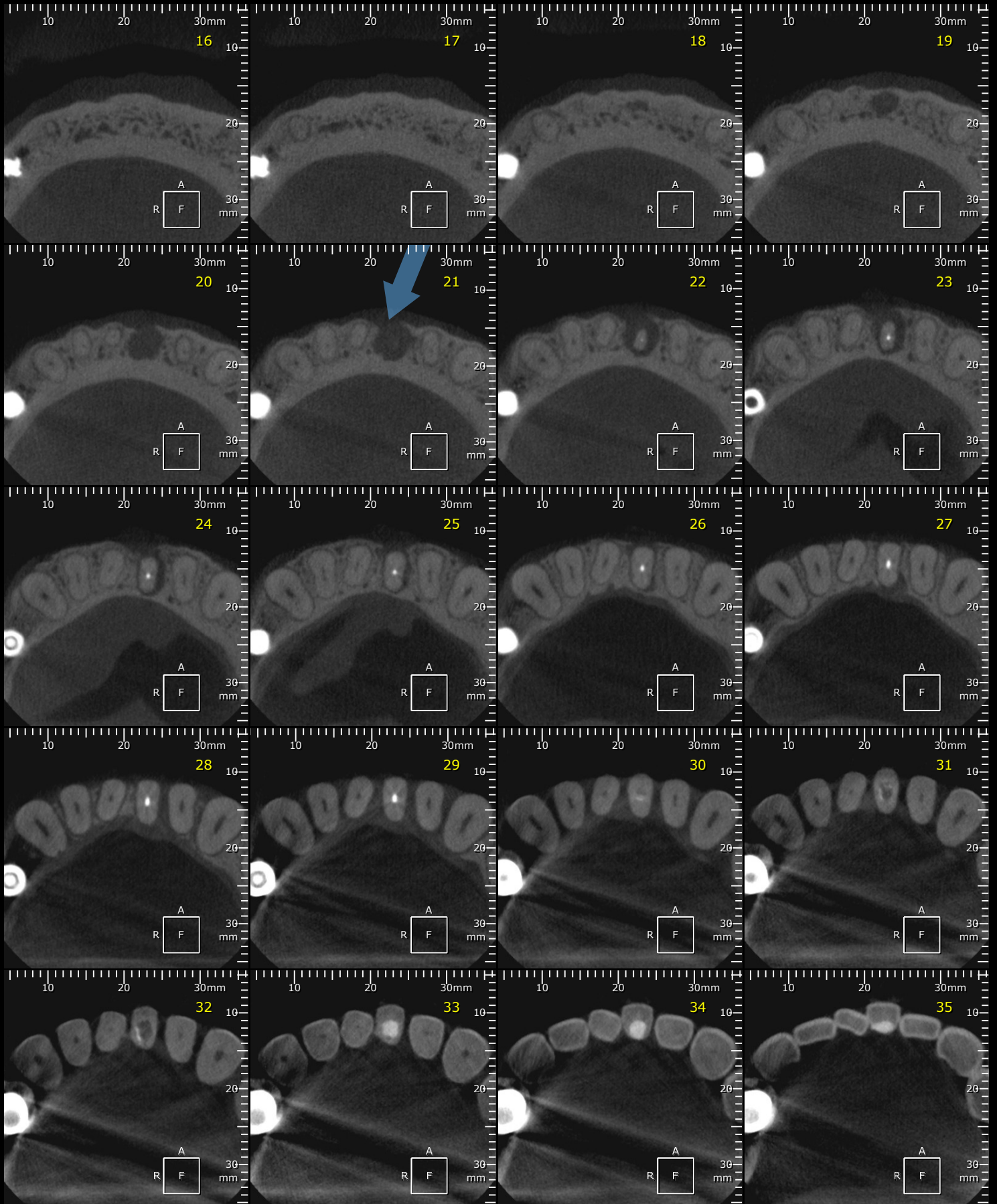
CORTES OBLÍQUOS (1:1), ESPESSAMENTO E ESPAÇAMENTO DE 1MM - TAMANHO REAL



Legendas: SM: Seio Maxilar | CN: Cavidade Nasal | CS: Canalis Sinuosus | CNP: Canal Nasopalatino | CM: Canal da Mandíbula | FM: Forame Mental

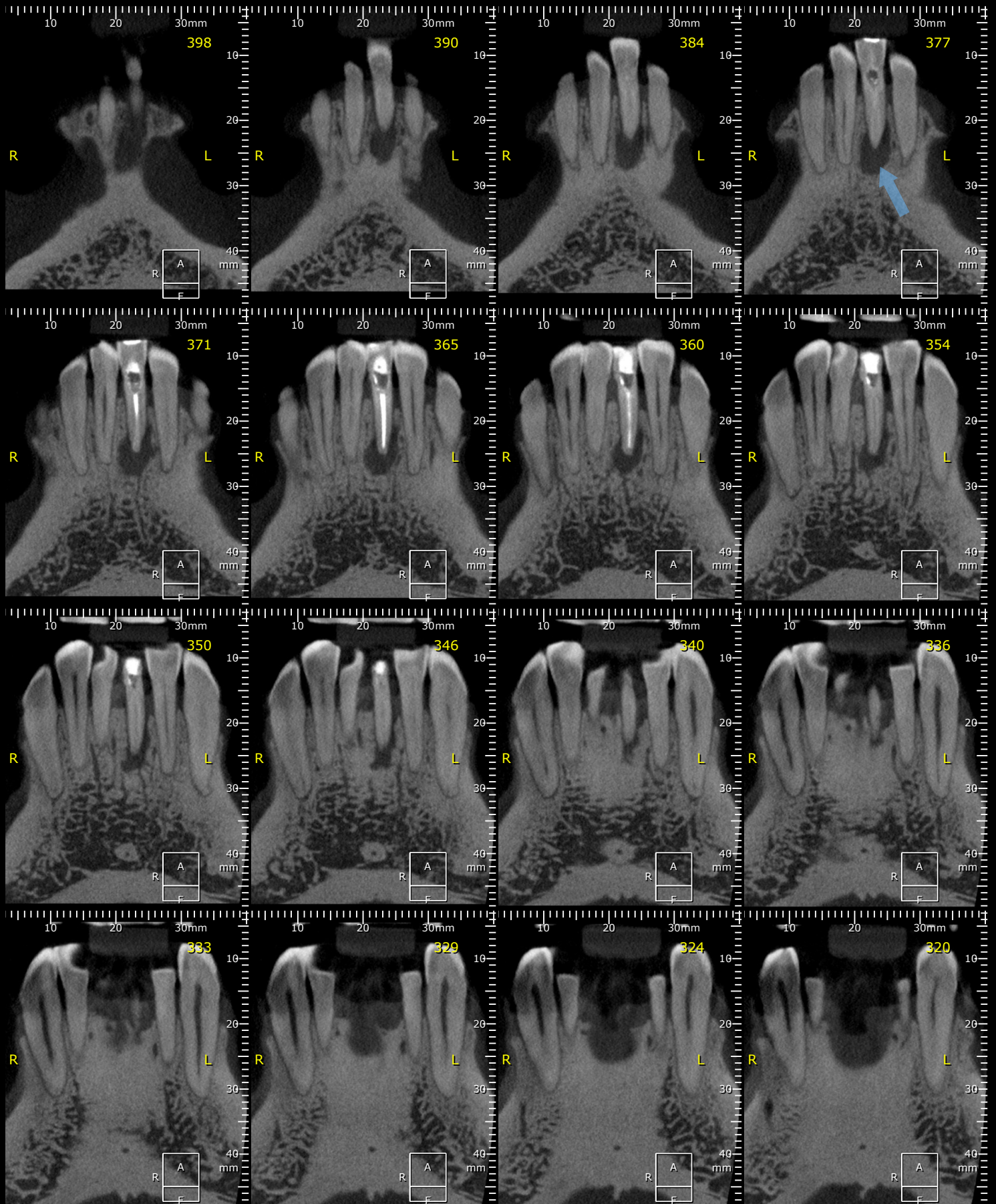
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

RECONSTRUÇÕES AXIAIS



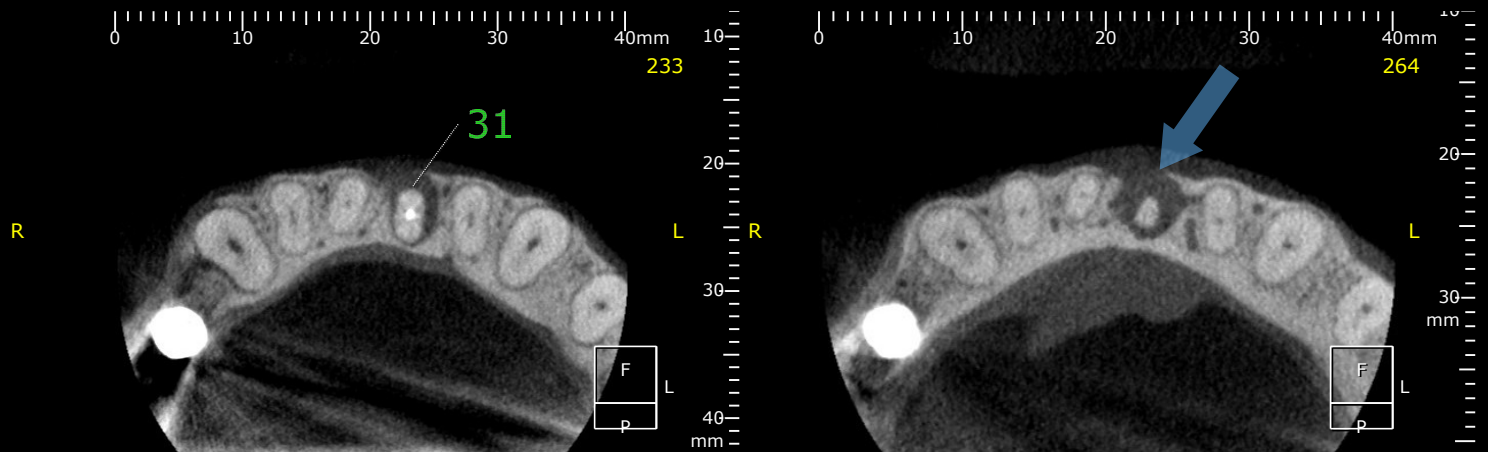
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

RECONSTRUÇÕES CORONAIS

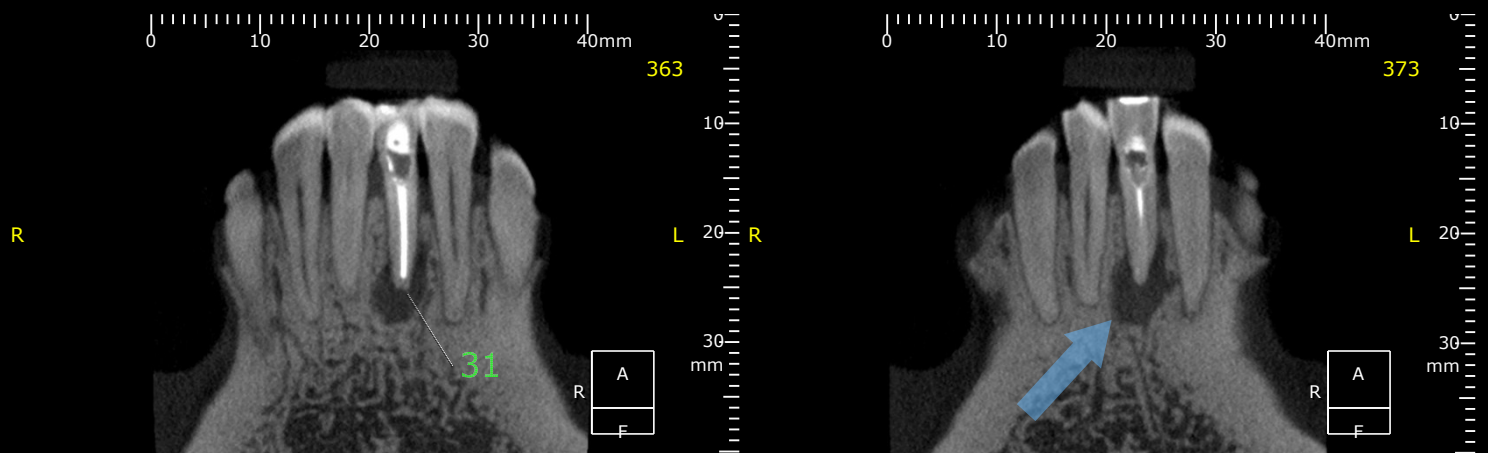


TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

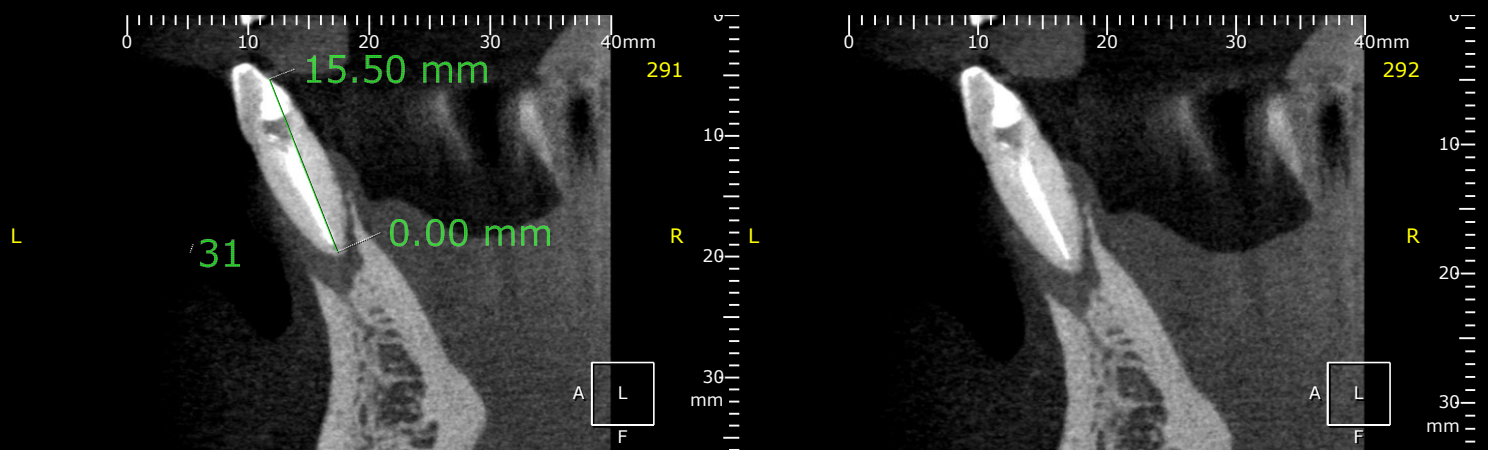
RECONSTRUÇÕES AXIAIS EXTRAS - DENTE 31



RECONSTRUÇÕES CORONAIS EXTRAS - DENTE 31



RECONSTRUÇÕES SAGITAIS EXTRAS - DENTE 31



TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM DO COMPLEXO DENTO-MAXILO-FACIAL

PROTOCOLO

Foram realizadas reconstruções multiplanares, demonstrando:

- Cortes transversais com 0,08 mm de espessura e 1 mm de afastamento entre eles. As imagens encontram-se na escala 1:1 (tamanho real) e numeradas em seu quadrante superior. As imagens coronais panorâmicas e/ou axiais de localização indicam a região correspondente aos cortes transversais, conforme a numeração apresentada entre a imagem de localização e o respectivo corte. Para o estudo, foi considerada a totalidade do volume adquirido, sendo as imagens geradas documentadas em templates específicos, que representam um resumo das imagens reformatadas selecionadas. Ressalta-se que o exame tomográfico constitui método auxiliar de diagnóstico, devendo seus achados ser interpretados em conjunto com os dados clínicos e demais exames complementares pertinentes.
- As reconstruções tridimensionais (3D) possuem caráter exclusivamente ilustrativo.

ÁREA DE ESTUDO SOLICITADA: 31

ANÁLISES GERAIS

- Dentes presentes na incidência solicitada: 42, 41, 31 e 32;
- Desgaste ou fratura da borda incisal no(s): 41, 31 e 32;
- Presença de restaurações sujeitas a avaliação clínica: 31;
- Dente 31: presença de material obturador hiperdenso no conduto radicular no limite apical; rarefação óssea de limites bem definidos no periápice, com descontinuidade da cortical óssea alveolar vestibular (vide corte axial 20 e 21 - seta azul), sugestiva de lesão periapical de origem inflamatória (granuloma ou cisto); Imagem compatível com espaço vazio ou presença de material hipodenso entre o material obturador hiperdenso na região cervical da raiz e o material restaurador hiperdenso da região de coroa; correlacionar com dados clínicos e história do paciente;
- Perda horizontal moderada das cristas ósseas alveolares. Sugere-se avaliação periodontal;
- Em algumas regiões foram realizadas mensurações ósseas, para medidas de outras regiões ou em outras inclinações basta utilizar uma régua milimetrada, já que os cortes apresentam tamanhos reais;
- Ressaltamos que o exame de tomografia computadorizada de feixe cônico, assim como qualquer exame por imagem, é um exame complementar, sendo as informações clínicas de fundamental importância para a conclusão do diagnóstico;

- Para melhor observação dos achados tomográficos descritos acima, sugere-se navegação tridimensional no arquivo DICOM, que segue em anexo ao exame.

OBSERVAÇÕES

- *As medidas apresentadas nos cortes transversais possuem caráter orientativo, devendo sua interpretação e utilização ser realizadas pelo Cirurgião-Dentista responsável, de acordo com o planejamento clínico e/ou cirúrgico-protético.*
- *Recomenda-se avaliação clínica dos achados tomográficos para melhor elucidação diagnóstica e adequado planejamento terapêutico.*
- *Ressalta-se que artefatos de imagem decorrentes de materiais odontológicos podem limitar a avaliação de determinadas estruturas. Recomenda-se criteriosa correlação dos achados tomográficos com os dados clínicos, radiografias periapicais, exames anteriores e demais exames complementares pertinentes.*

Atenciosamente.

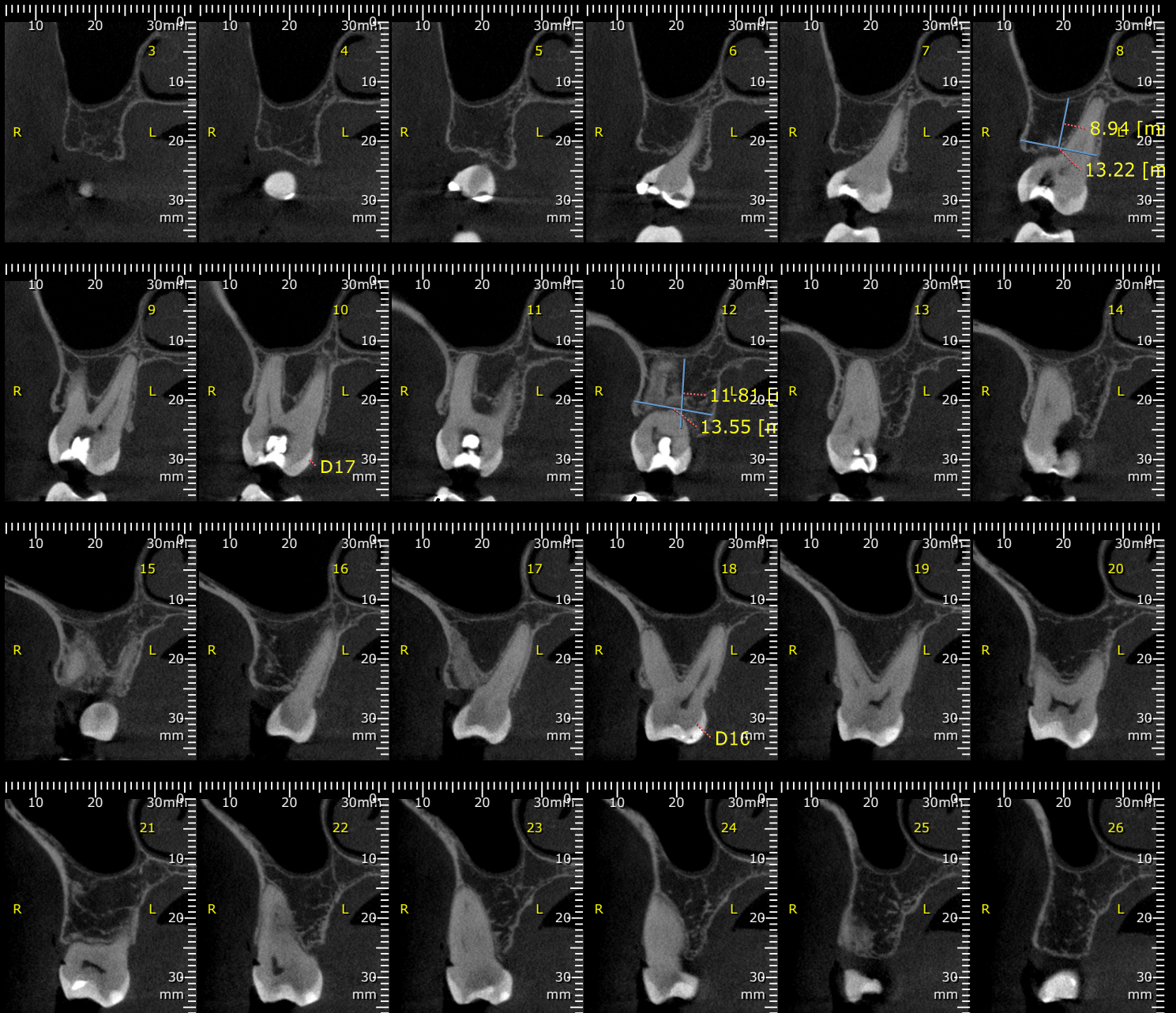


Ms. Sávio Bisinoto de Leles
Mestre e Esp. em Ortodontia
Esp. em Radiologia e Imaginologia Odontológica
CROGO - 15026

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM



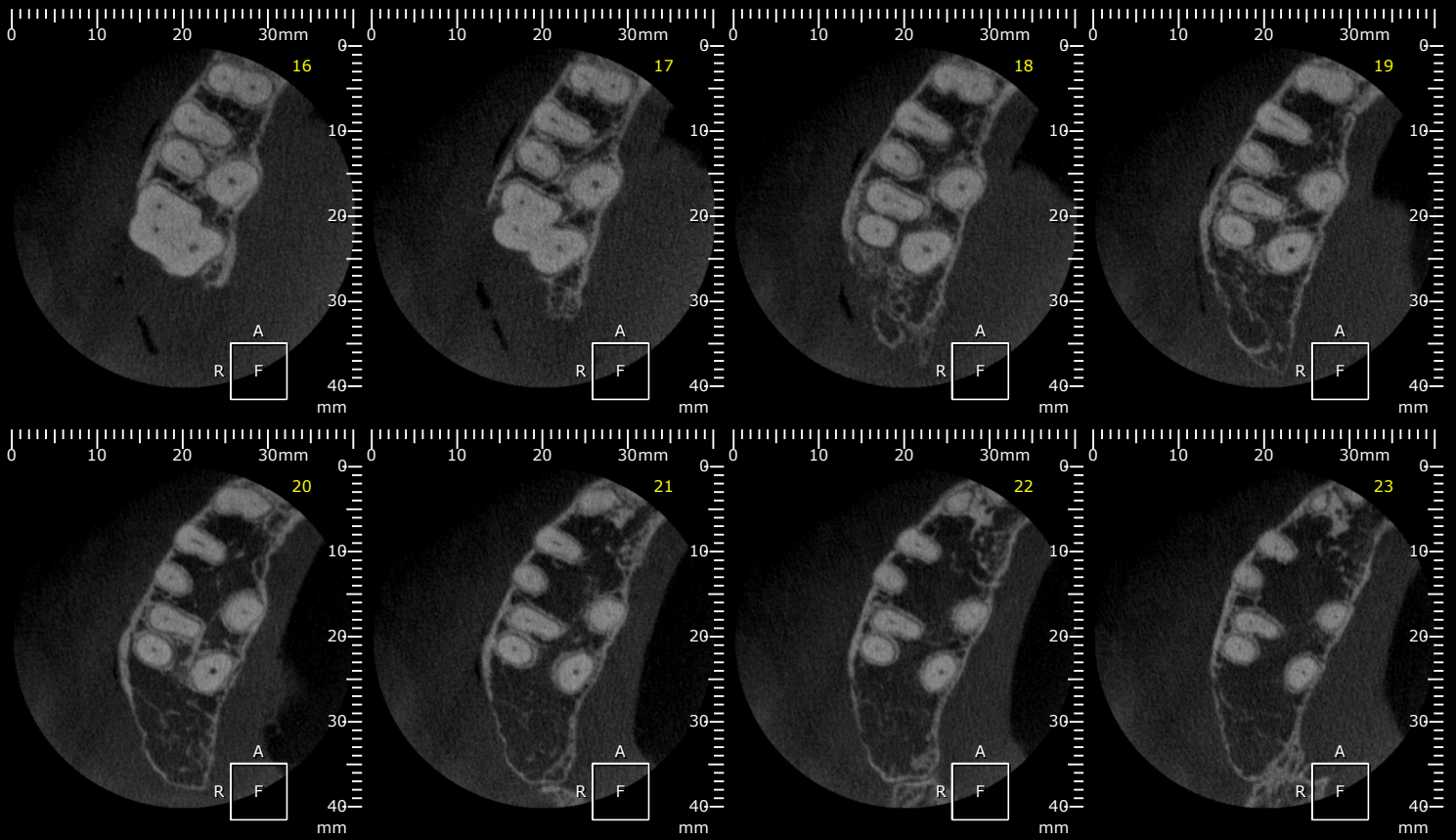
CORTES OBLÍQUOS (1:1), ESPESSAMENTO E ESPAÇAMENTO DE 1MM - TAMANHO REAL



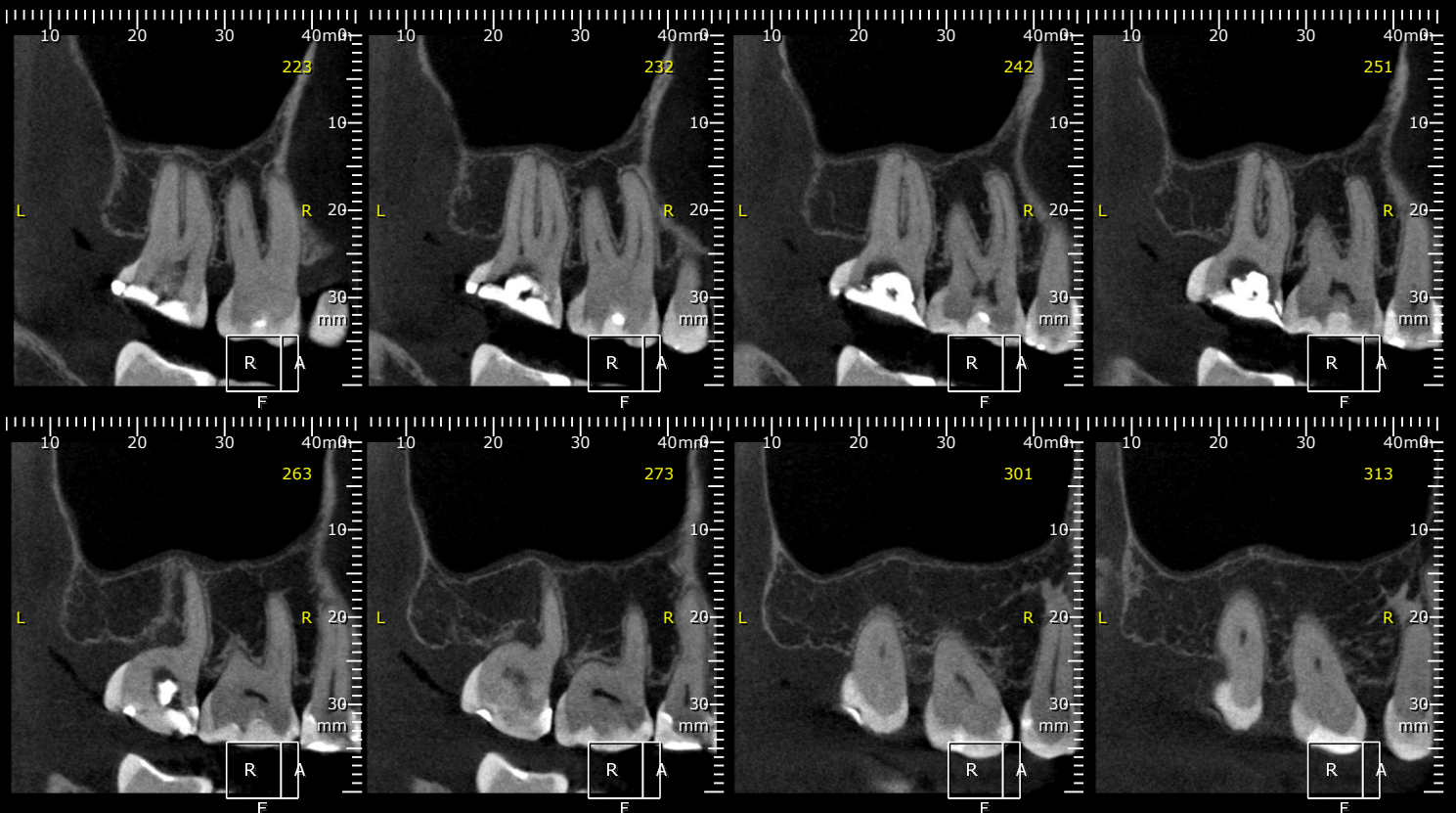
Legendas: SM: Seio Maxilar | CN: Cavidade Nasal | CS: Canalis Sinuosus | CNP: Canal Nasopalatino | CM: Canal da Mandíbula | FM: Forame Mental

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

RECONSTRUÇÕES AXIAIS

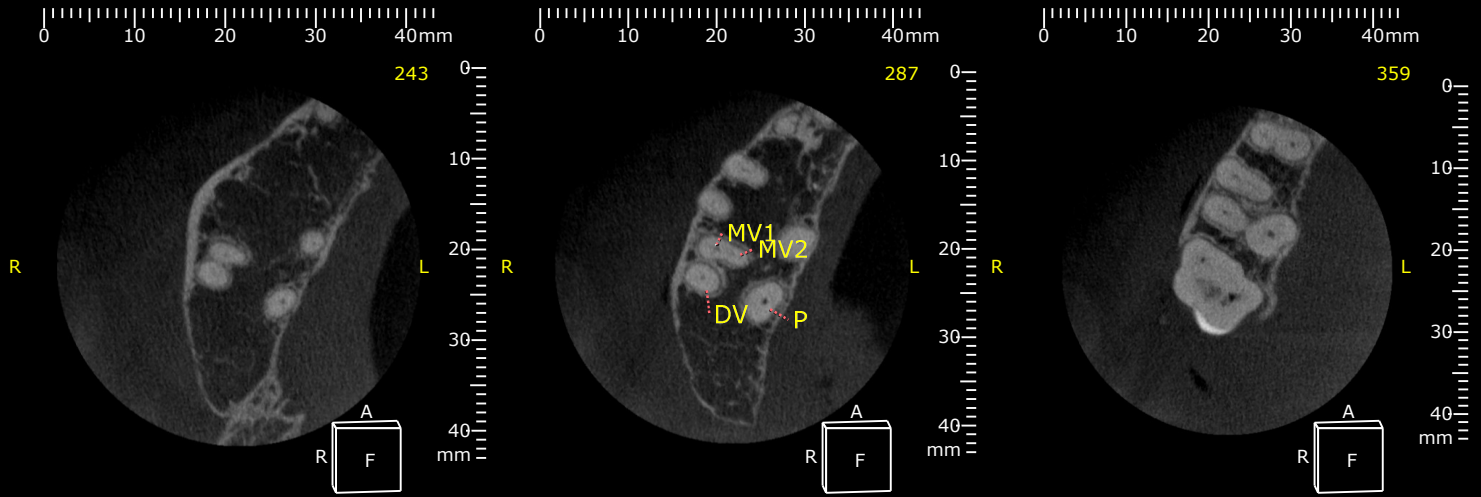


RECONSTRUÇÕES SAGITAIS

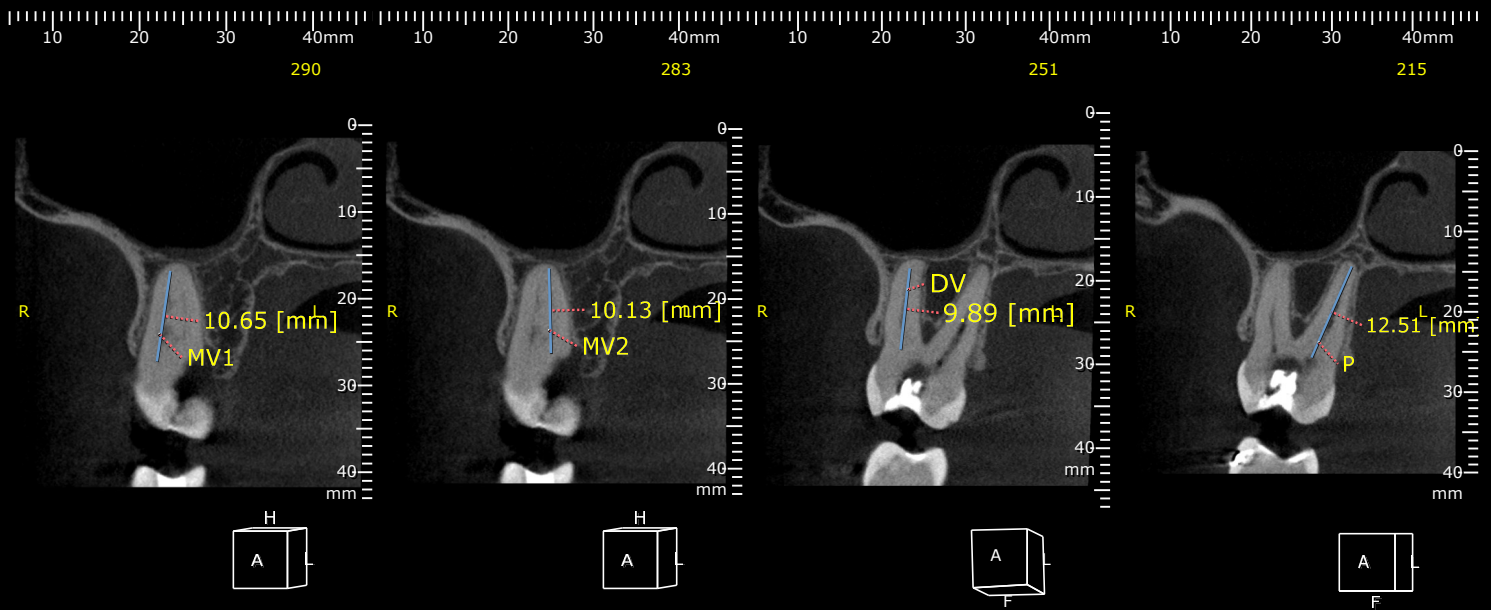


TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

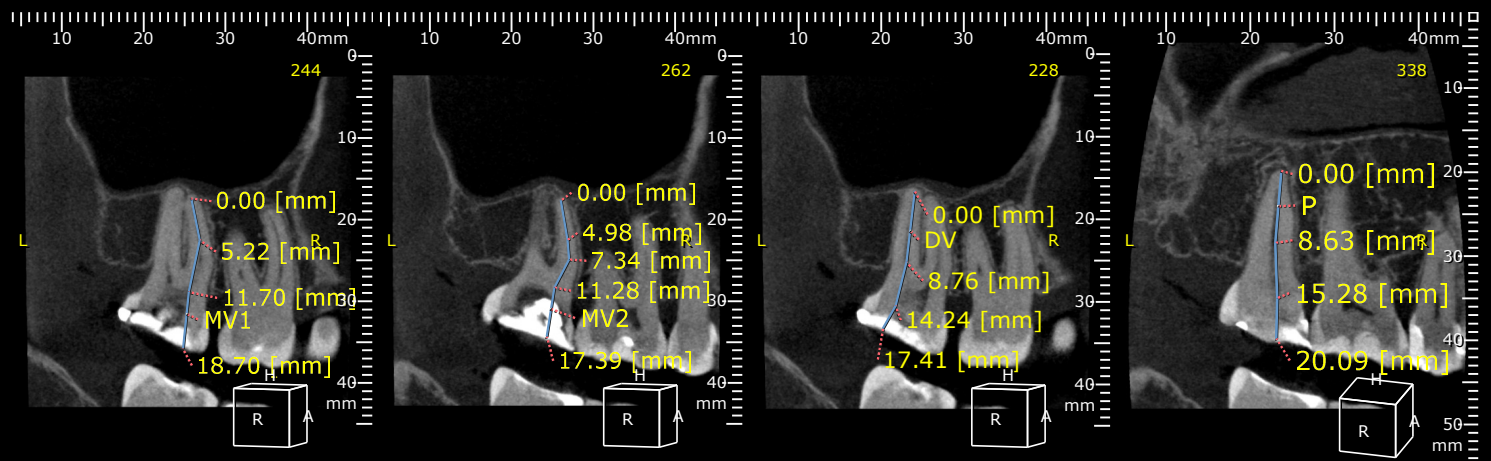
RECONSTRUÇÕES AXIAIS EXTRAS - DENTE 17



RECONSTRUÇÕES CORONAIS EXTRAS - DENTE 17



RECONSTRUÇÕES SAGITAIS EXTRAS - DENTE 17



TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM DO COMPLEXO DENTO-MAXILO-FACIAL

PROTOCOLO

Foram realizadas reconstruções multiplanares, mostrando:

- Cortes transversais de 0,08mm de espessura com 1mm de afastamento entre eles. Estes cortes estão na escala 1:1 (tamanho real) e numerados no seu quadrante superior. A imagem coronal panorâmica e/ou axial localiza, onde foram realizados os cortes transversais, estão relacionados com os números indicados entre a imagem de localização e o corte. Para o estudo observou-se a totalidade do volume adquirido, sendo que as imagens geradas encontram-se documentadas em templates específicos que por sua vez representam um resumo de imagens reformatadas selecionadas. O exame tomográfico é um exame auxiliar, suas observações são consideradas sugestivas, portanto necessitam de confirmação clínica.
- As imagens de reconstrução 3D, sendo apenas de caráter ilustrativo.

ÁREA DE ESTUDO: 17

ANÁLISES GERAIS

- Dente(s) ausente(s): 18;
- Presença de material restaurador hiperdenso na coroa do(s) dente(s): 17 e 16;
- Discreta linha hipodensa no terço cervical, iniciando na mesial do dente 17, estendendo-se para distal até embocadura do canal disto vestibular, compatível com trinca radicular. Se faz necessário ressaltar que o artefato de imagem gerado pela presença do material hiperdenso no elemento pode mascarar possível existência de trinca/ fratura radicular bem como a presença de canal lateral/ colateral. Dados confirmados somente clinicamente.
- Seio maxilar direito com aspecto de normalidade.
- Em algumas regiões foram realizadas mensurações ósseas, para medidas de outras regiões ou em outras inclinações basta utilizar uma régua milimetrada, já que os cortes apresentam tamanhos reais.
- Ressaltamos que o exame de tomografia computadorizada de feixe cônico, assim como qualquer exame por imagem, é um exame complementar, sendo as informações clínicas de fundamental importância para a conclusão do diagnóstico;
- Para melhor observação dos achados tomográficos descritos acima, sugere-se navegação tridimensional no arquivo DICOM, que segue em anexo ao exame.

CONCLUSÃO

- *As medidas nos cortes transversais são somente uma sugestão, compete exclusivamente ao Implantodontista/Cirurgião-Dentista determinar a necessidade, posição, inclinações e diâmetros dos implantes, de acordo com o planejamento cirúrgico/protético.*
- *Recomenda-se avaliação clínica dos resultados obtidos no exame tomográfico para melhor elucidação do diagnóstico.*

- Ressaltamos que os artefatos de imagem gerados pela estrutura metálica, coroas protéticas, retentor radicular, bráquetes e material obturador intracanal podem levar a um resultado falso negativo ou positivo para trinca radicular e lesões cariosas. Sugere-se criteriosa correlação dos cortes tomográficos e radiografias periapicais com os dados clínicos, comparar com imagens anteriores e exames complementares.

Atenciosamente



Ms. Sávio Bisinoto de Leles
Mestre e Esp. em Ortodontia
Esp. em Radiologia e Imaginologia Odontológica
CROGO - 15026